

Polybrene 及抗人球蛋白介质中与抗-E 及抗-Fya 抗原细胞均出现凝集。②血清与E 抗原阳性Fya 阴性细胞吸收放散试验:取患者血清2 滴与E 抗原阳性Fya 阴性细胞1 滴(O、ccDEE、Fy(a⁻b⁺) 在37℃吸收30min,吸收后的血清与O、ccDEE、Fy(a⁻b⁺)细胞在盐水、抗人球蛋白及Polybrene 介质中均无凝集;其乙醚放散液与O、ccDEE、Fy(a⁻b⁺)细胞在Polybrene 及抗人球蛋白介质中凝集(+++~++),证明血清中含有IgG 性质的抗-E 抗体。③血清与O、ccDee、Fy(a⁺b⁻)细胞吸收与放散试验:取患者血清2 滴与3 次洗涤后O、ccDee、Fy(a⁺b⁻)细胞在37℃吸收30min,吸收后的血清与O、ccDee、Fy(a⁺b⁻)细胞在盐水、抗人球蛋白及Polybrene 介质中均无凝集;其乙醚放散液与O、ccDee、Fy(a⁺b⁻)细胞在Polybrene 及抗人球蛋白介质中凝集(+++~++),结果证实血清中含有IgG 性质的抗-Fya。④确认试验:患者红细胞分别与抗-E 及抗-Fya 标准血清反应,结果均为阴性。⑤抗体效价:抗-E:取O、ccDee、Fy(a⁻b⁺)细胞与倍比稀释的患者血清在抗人球蛋白介质中测得效价为16;抗-Fya:取O、ccDee、Fy(a⁺b⁻)细胞与倍比稀释的血清在抗人球蛋白介质中测得效价为32。⑥患者血液与供血者配血试验:患者与2 名O 型、ccDee、Fy(a⁻b⁺) 在盐水、Polybrene 及抗人球蛋白介质中配血,均无凝集、溶血,输入400ml 血后无不良反应。

讨论:抗-E 是Rh 血型系统中较常见的抗体,除少数为天然产生外大多由输血及妊娠免疫产生,属免疫性抗体;抗-FyaD 是血型系统中少见IgG 性质的抗体,二者均可导致即发或迟发性溶血反应,并有引起新生儿溶血病的危险,各项实验结果显示,患者血清中含有IgG 性质的抗-E 及抗-Fya 抗体,其原因为输入了含有E、Fya 抗原阳性红细胞,因此,应积极开展Polybrene、抗人球蛋白介质配血法;观察结果时应轻微震荡试管,以防类似抗体漏检,有条件者最好行微珠凝胶试验,确保输血安全。

自拟米粉炒黄治疗婴幼儿单纯性腹泻

张文成,刘绪娟,高洪雁

(济南市槐荫区人民医院,山东济南 250021)

2001~2004 年,我们采用民间验方米粉炒黄治疗婴幼儿单纯性腹泻,效果满意。现报告如下。

临床资料:本组280 例患儿具备以下条件:①年龄<2 岁;②病程1 周~3 个月;③腹泻3~10 次/d;④大便稀散,呈稀水糊状或蛋花样,或夹有不消化食物,但无黏液、脓血,大便常规检查不含红、白细胞或偶有数个白细胞,细菌培养阴性;⑤无发热、腹痛、呕吐,食欲尚好,脱水程度为轻度;⑥其他治疗疗效不佳。280 例患儿中,男158 例,女122 例;年龄≤0.5 岁82 例,0.5~1 岁122 例,1~2 岁76 例;疗程7~14d 135 例,~30d 66 例,~60d 52 例,~90d 27 例。随机分为对照组94 例观察组186 例。两组性别、年龄、病程无差异, $P<0.05$ 。方法:两组均

用多酶片(<1 岁1/3 片,1~2 岁1/2 片)、乳酶生(<1 岁0.3g,1~2 岁0.6g)、维生素B₁(均15mg),均3 次/d;根据有无脱水口服ORS 液。观察组加用炒黄的米粉适量加水煮沸至稠糊状,根据年龄及日常饮食量,每日次数至不许添加其他食品或仅加食1~2 次母乳(或奶制品、粥、烂饭),以能饱为准。转好后逐渐减量,并过度到完全日常饮食,而且无腹泻为止。服药3~7d。门诊定期复查或随访。结果:观察组痊愈(大便成形,腹泻次数减少至≤2 次/d,大便镜检无异常,临床症状完全消失)113 例,有效(大便次数减少一半以上,且含水量明显减少,镜检偶见白细胞,临床症状基本消失)50 例,无效(大便次数及水分不减少或症状加重)23 例,总有效率为87.63%;对照组痊愈18 例,有效14 例,无效62 例,总有效率34.04%。两组总有效率比较($P<0.01$)。

讨论:婴幼儿新陈代谢旺盛,所需营养物质相对较多,但胃肠功能相对较弱,神经系统对胃肠道的调节功能亦差,易导致腹泻。单纯性腹泻多由非感染因素所致,抗生素效果不佳。中医认为:“泄之本无不由于脾胃”,脾胃健则消化正常,脾虚失运而泄泻。米粉炒黄治疗小儿腹泻自古有之,粳米具有健脾养胃、固肠止泻之功能,经炒黄后能增强其固肠止泻功能。现代研究证明,粳米含有大量的烟酸、维生素B₁、维生素B₂ 以及磷、铁等无机盐;其含有的碳水化合物及脂肪等有利于婴儿的发育,且能刺激胃液分泌,有助于消化,可促进脂肪吸收及奶粉中的酪蛋白形成舒松而柔软的小凝块,使之容易消化吸收。《本草纲目》有“益胃除湿”的记载,因而炒米粉对婴幼儿腹泻有显著的治疗作用。本研究显示,单纯应用多酶片、乳酶生及维生素B₁ 亦有一定的效果,可作为治疗本病的辅助药物。本法适用于轻中型单纯性腹泻、重型及有感染者。

中西医结合治疗慢性盆腔感染

90 例疗效观察

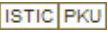
梁慧敏

(内黄县妇幼保健院,河南内黄 456300)

2003 年5 月~2004 年6 月,笔者采用中西医结合治疗慢性盆腔感染患者90 例,效果满意。现报告如下。

资料与方法:本组慢性盆腔感染患者90 例,年龄22~50 岁,病程3~10a。参照乐杰主编《妇产科学》第6 版中的标准进行诊断:①患者有急性盆腔炎病史;②下腹坠胀痛、腰骶酸痛,常在劳累、性交后或月经前后加重;③月经紊乱,经期延长,白带多,黄色或脓性;④子宫压痛,一侧或双侧附件增厚或增粗,呈条索状或扪及不活动的包块、压痛;⑤B 超检查,附件区探及异常回声或不规则暗区,子宫直肠陷凹有积液。以上几项中有3 项以上即可确诊。确诊后采用第三代头孢菌素类头孢曲松钠2g 溶于100ml 生理盐水静滴,1 次/d,甲硝唑0.5g 静滴,2 次/d,连用7d,经期巩固治疗2 个疗程。炎症控制后用中药:败酱草、半枝莲、红藤各30g,蒲公英、赤芍、牡丹皮、枳壳各15g,桃仁10g。有包块者加莪术、三棱各10g;腹痛明显者加香附12g,木香9g 后下;发热者加黄柏12g,金银花15g;白带量多者

自拟米粉炒黄治疗婴幼儿单纯性腹泻

作者: 张文成, 刘绪娟, 高洪雁
作者单位: 济南市槐荫区人民医院, 山东, 济南, 250021
刊名: 山东医药 
英文刊名: SHANDONG MEDICAL JOURNAL
年, 卷(期): 2005, 45 (32)

本文读者也读过(6条)

1. 孙雄 中西医结合治疗小儿秋季腹泻68例临床观察[期刊论文]-[中医儿科杂志](#)2008, 4 (5)
2. 乔善宝. 王庆东. 焦昌梅. QIAO Shan-bao. WANG Qing-dong. JIAO Chang-mei 荧光猝灭法测定婴幼儿米粉中的铁[期刊论文]-[化学世界](#)2010, 51 (1)
3. 吴婷. 李玉伟. 李凤琴. 计融. 张立实 我国市售婴幼儿乳粉和米粉微生物污染水平研究[期刊论文]-[现代预防医学](#)2006, 33 (7)
4. 孙忠伟. 李春杰. 邵景海. 王占东 婴幼儿营养米粉量化冲调方法的研究[期刊论文]-[中国食品工业](#)2008 (7)
5. 詹斌 高蛋白早籼米粉系列产品的开发[期刊论文]-[农村新技术](#)2009 (4)
6. 国家质检总局. 产品质量监督司 婴幼儿米粉产品质量国家监督抽查结果[期刊论文]-[食品工业科技](#)2004 (12)

引用本文格式: 张文成. 刘绪娟. 高洪雁 自拟米粉炒黄治疗婴幼儿单纯性腹泻[期刊论文]-[山东医药](#) 2005 (32)